

05 - 05- LA SCIATIQUE PAR HERNIE DISCALE - Pr. Ghannane

Alors nous allons continuer notre programme de pathologie neurochirurgicale et le cours d'aujourd'hui, il traitera la sciatique par Hernie Discal. Alors la sciatique, c'est une douleur ressentie dans le territoire du nerf sciatique par compression radiculaire de la racine nerveuse L5 ou S1. C'est une infection très fréquemment rencontrée en pratique médicale courante.

Elle peut être vue par le médecin généraliste, par le médecin neurochirurgien, par les rhumatologues, par les traumatologues. Donc c'est une pathologie fréquemment rencontrée en pratique médicale courante. Son diagnostic est clinique, il est basé sur l'interrogatoire et l'examen du malade.

Et toute sciatique, il peut être dû à une Hernie Discal, mais il peut être dû à d'autres causes non discales. Et donc, la sciatique par Hernie Discal, il peut poser un problème de diagnostic différentiel avec d'autres causes de sciatique dites non discales. Cette pathologie, elle est parfois grave parce qu'elle expose un risque de syndrome de la queue de cheval.

Rappelez-vous, quand on a traité le syndrome de la queue de cheval, nous avons dit que parmi les causes du syndrome de la queue de cheval, l'Hernie Discal, il peut en être une. C'est une cause majeure d'invalidité et d'absentéisme professionnel. Et donc, ça peut avoir un retentissement socioprofessionnel important sur le malade et sur son entourage aussi.

Alors un petit rappel anatomique, vous savez que la colonne vertébrale lombaire, elle est formée par l'empilement de vertèbres lombaires les unes sur les autres, séparés par un disque intervertébral. Et ce disque intervertébral, il est formé par deux composantes, un noyau central, dit nucleus pulposus, entouré par un anneau fibreux, dit annulus fibrosus. Et puis, autre notion, c'est que dans le canal rachidien lombo-sacré, nous avons les racines de la queue de cheval, à partir desquelles naissent les racines nerveuses lombaires et sacrées.

Alors sur le plan épidémiologique, la sciatique par hernie discale représente 25 à 30% de l'activité opératoire, à peu près le tiers de l'activité opératoire des services de neurochirurgie. On diagnostique à peu près 100 000 nouveaux cas par an de sciatique par hernie discale et 37 000 interventions chirurgicales par année. Cette pathologie se voit beaucoup plus fréquemment chez les sujets âgés entre 30 et 50 ans.

Elle se voit rarement chez les sujets âgés de moins de 20 ans. Le sexe masculin est plus touché que le sexe féminin. Et il y a des professions qui exposent plus à la survenue de sciatique par hernie discale.

Ce sont les individus qui présentent une activité manuelle de force, les sujets qui pratiquent les activités ménagères. Il existe des facteurs favorisant la survenue de sciatique par hernie discale, parmi lesquels on a les anomalies transitionnelles. Vous savez que le plus fréquemment, nous avons 5 vertèbres lombaires et 5 vertèbres sacrées.

Ce sont les statistiques les plus fréquentes. Mais certains malades ont ce qu'on appelle une anomalie transitionnelle, c'est-à-dire ceux qui ont soit 1 vertèbre lombaire de moins ou 1 vertèbre lombaire de plus. Il y a des sujets qui ont 4 vertèbres lombaires et 6 vertèbres sacrées, et d'autres qui ont 6 vertèbres lombaires et 4 vertèbres sacrées.

Ceux-ci ont des anomalies transitionnelles. Les sujets qui ont un canal lombaire étroit sont plus exposés à faire des hernies de sciatique par hernie discale. Les sujets qui ont ce qu'on appelle des spondylolisthesis.

Ce qu'est un spondylolisthesis, c'est un glissement d'une vertèbre par rapport à l'autre. Ces sujets qui ont ces spondylolisthesis, ces glissements vertébraux, sont plus exposés à faire des sciatiques par hernie discale. Les sujets qui ont des troubles de la statique rachidienne, notamment ceux qui présentent une scoliose, c'est-à-dire une déviation latérale du rachis, ceux-ci sont plus exposés à faire des sciatiques par hernie discale que les sujets qui n'en ont pas.

Et puis, il y a les traumatismes professionnels et sportifs. Par exemple, les sujets qui font de la gymnastique, les sujets qui font le ski, sont plus exposés à faire des sciatiques par hernie discale. Et puis, comme facteur favorisant, sachez que l'obésité est un facteur qui peut favoriser la survenue de sciatiques par hernie discale.

Sur le plan physiopathologique, la sciatique par hernie discale est due à une migration du nucleus fibrosis, c'est-à-dire du noyau central du disque intervertébral à travers l'annulus fibrosis. Ça veut dire que si ce sujet, on assiste à une altération discale, c'est-à-dire une déshydratation du disque, suite à cette déshydratation, l'anneau fibreux, c'est-à-dire l'annulus fibrosis, il va se fissurer, et à travers cette fissure, on va assister à une migration du noyau central, c'est-à-dire du nucleus pulposus, qui va migrer et va comprimer la racine nerveuse en regard et générer la douleur, c'est-à-dire la sciatique. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on a une hernie discale ? Alors, cette hernie discale, elle va être responsable d'abord d'un roufflement et d'une distension du ligament vertébral commun postérieur.

Ce roufflement et cette distension du ligament vertébral commun postérieur, il va être à l'origine d'une douleur du rachis lombaire ou sacrée, et d'une contracture du muscle para-vertébraux. Et si cette douleur du rachis lombaire et cette contracture du muscle para-vertébraux, il va être responsable de ce qu'on appelle un lombago. Donc, à côté de ce lombago, cette migration et cette hernie discale, elle va être à l'origine de ce qu'on appelle un conflit entre le disque et la racine.

Et donc, ce conflit entre le disque et la racine, c'est lui qui est responsable de la sciatologie, c'est-à-dire de la douleur radiculaire et donc de la sciatique. Donc, cette souffrance radiculaire, il va s'expliquer par l'action mécanique de la hernie discale sur la racine, par la réaction inflammatoire que cette migration, que cette hernie discale va générer sur la racine, et par aussi une altération circulatoire. Ça vous rappelle en quelque sorte ce qu'on avait dit dans la compression médullaire.

Sauf que dans la compression médullaire, c'est la moelle qui est comprimée. Dans la sciatique par hernie discale, c'est la racine qui est comprimée. Et quand la racine est comprimée, elle va subir une action mécanique, une action inflammatoire et aussi une action vasculaire ou circulatoire.

Sur le plan anatomopathologique, quel est l'aspect de la hernie discale ? Alors, le nucléus pulposus, il est déshydraté, il est atrophié et il est écrasé. Et l'annulus fibrosus, c'est-à-dire l'anneau fibreux, il est fissuré. Et donc c'est à travers cette fissure qu'on va migrer ce nucléus pulposus déshydraté, atrophié et écrasé.

Alors le siège de la hernie discale, les sièges les plus fréquents sont l'espace L4, L5 ou L5, S1. Et donc cette hernie, elle peut être médiane, elle est le plus fréquemment latérale, elle peut être foraminale ou extra-foraminale. Alors quelles sont les manifestations cliniques de la sciatique par hernie discale ? Alors, comme signe fonctionnel, c'est-à-dire les signes qui sont rapportés par le malade et qui sont mis en évidence par l'interrogatoire du patient.

On va retrouver des lombalgies, c'est-à-dire des douleurs lombaires qui évoluent par crise. Et ces lombalgies, elles sont associées à des radiculalgies, c'est-à-dire des douleurs radiculaires qui intéressent un et ou les deux membres inférieurs suivant le siège de la hernie. Ces radiculalgies, elles sont spontanées ou survenues suite à un facteur déclenchant, par exemple un effort de soulèvement d'une charge lourde.

Et ces radiculalgies, elles viennent aggraver les lombalgies et puis après elles deviennent isolées, c'est-à-dire que le malade va présenter des lombalgies. Ensuite les lombalgies, elles vont être suivies par des radiculalgies. Puis les lombalgies, elles vont disparaître et le malade, il gardera uniquement des radiculalgies.

Ces radiculalgies, elles peuvent être brutales ou progressives et elles sont rapportées différemment par les malades. Elles sont décrites comme des élancements des membres inférieurs, des étirements ou le plus fréquemment, elles sont ressenties comme des décharges électriques ressenties par le malade au niveau des membres inférieurs. Ces radiculalgies, elles sont mécaniques, c'est-à-dire au moins au début, elles s'exacerbent à l'effort et elles s'estompent et diminuent avec le repos.

Et elles sont, comme on dit, impulsives, c'est-à-dire qu'elles augmentent à l'effort de toux ou de défécation. Lorsque le malade tousse ou lorsqu'il va à la selle, il ressent que la douleur, la radiculalgie, elle s'exacerbe au niveau de leurs membres inférieurs. Alors le trajet de la douleur, il est différent selon la racine qui est comprimée.

Lorsque la racine comprimée est L5, la douleur, il commence au niveau lombaire, il irradie à la face postéro-externe de la cuisse, à la face externe de la jambe, le dos du pied et il se termine au niveau du gros orteil. Lorsque c'est la racine S1 qui est comprimée, la douleur, il commence au niveau de la région lombaire, il intéresse la face postérieure de la fesse, la face postérieure de la cuisse, la face postérieure de la jambe, la plante du pied et il se termine au niveau des

derniers orteils. À côté de ces lombes algées et radiculalgies, le malade peut apporter des signes subjectifs sous forme de fourmillement, on dit aussi des parésthésies, on dit que le malade a des radiculalgies parésthésiantes et il faut dans l'interrogatoire chercher l'existence de troubles génitosphinctériens que s'ils existent, ils doivent nous orienter vers une sciatique par hernie discale compliquée par un syndrome de la cote cheval.

Un autre signe qui est important, c'est que dans la sciatique par hernie discale, on n'a jamais de signes généraux, c'est-à-dire on n'a jamais d'altération de l'état général, jamais de fièvre, jamais de signes généraux. Après les signes fonctionnels recherchés par l'interrogateur, on passe à l'examen physique et à la recherche de signes physiques. L'examen doit intéresser le rachis à la recherche d'une attitude ontalgique que le malade adopte pour être soulagé.

Cette attitude ontalgique doit être recherchée dans le plan sagittal, en recherchant une position penchée vers l'avant ou vers l'arrière ou bien dans le plan frontal, c'est-à-dire un rachis qui est dévié vers le côté droit ou vers le côté gauche. C'est ce qu'on appelle une attitude ontalgique que le malade adopte pour être soulagé. On recherche aussi une raideur lombaire basse.

On recherche une contracture des muscles paravertébraux et on cherche ce qu'on appelle un signe de la sonnette. C'est quoi un signe de la sonnette ? C'est un signe qui consiste en une pression exercée à 2 ou 3 cm en paravertébral à travers lequel on essaye de réveiller la douleur vers le membre inférieur. Si on appuie là et le malade dit qu'il sent une douleur irradiant le long de son membre inférieur, on dit que le malade a un signe de la sonnette positif.

À côté de l'examen du rachis, il faut pratiquer un examen neurologique. On commence par l'appréciation de la marche sur les pointes et sur les talons pour essayer de voir s'il y a un déficit moteur des membres inférieurs ou non. On apprécie aussi la sensibilité du territoire douloureux de tous les membres.

On apprécie la sensibilité au niveau de la région de la selle et des organes génitaux externes. Pourquoi ? Pour essayer de chercher s'il y a une anesthésie en selle. S'il y a une anesthésie en selle, ça veut dire que le malade a une sciatique par hernie discale compliquée par un syndrome de la queue de cheval.

On doit être sûr qu'il n'y a pas de signe d'irritation périmidale parce que la sciatique par hernie discale, c'est une compression d'une racine et donc c'est un syndrome neurologique périphérique. Et donc quand on a un syndrome neurologique périphérique, il faut être sûr qu'il n'y a pas de signe d'irritation périmidale, notamment pas de signe de Babinski. Donc, l'examen neurologique et on cherche ce qu'on appelle un signe de la seigle.

C'est quoi le signe de la seigle ? C'est une manœuvre à travers laquelle on cherche à réveiller la douleur en étendant le membre inférieur du malade par rapport à l'horizontale. Et on essaie de calculer cet angle que forme le membre inférieur avec le plan horizontal à partir duquel on réveille la douleur sciatique. Donc, à côté de l'examen du rachis et l'examen neurologique, il faut faire un examen somatique complet pour être sûr que le malade n'a pas de signe

généraux.

Et donc, on examine la musculature abdominale, on s'assure de la présence des pouls artérielles au niveau du membre inférieur, on doit examiner la hanche et les articulations sacroiliaques, on fait même un toucher pilviens. Et l'examen de tous ces appareils doit être normal dans la sciatique par hernie discale. Alors, quel bilan paraclinique demander chez un patient présentant une suspicion de sciatique par hernie discale ? On commence par les examens radiologiques, notamment la radiographie standard du rachis lombaire et sacré face, en incidence de face et de profil.

On réalise aussi un examen de bassin de face. Cette radiographie standard va nous renseigner sur l'état du rachis, notamment sa statique, l'intégrité osseuse et éventuellement la recherche d'une anomalie transitionnelle, c'est-à-dire une lombalisation de S1 avec 6 vertèbres lombaires ou une sacralisation de L5 avec 4 vertèbres lombaires et 5 et 6 vertèbres sacrés. Sur cette radiographie standard, on analyse le disque intervertébral et sur la radiographie de bassin de face, on s'assure de l'intégrité des articulations sacroiliaques et des articulations coxo-fémorales parce que si l'articulation sacroiliaque est malade et l'articulation coxo-fémorale est aussi malade, ils peuvent simuler un tableau de sciatique par hernie discale.

Alors ça c'est une radiographie du rachis lombaire et sacré de face où on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 vertèbres lombaires. On dit qu'un malade qui a une anomalie transitionnelle type lombalisation de S1. À côté donc de la radiographie standard du rachis et du bassin, on peut demander une tomodensitométrie lombosacrée et cette tomodensitométrie lombosacrée, elle est généralement suffisante pour confirmer le diagnostic de la hernie discale.

Là on a un scanner lombaire où on reconnaît le corps vertébral, les massifs articulaires, le canal rachidien et la hernie discale, elle est là. Là on voit la hernie discale lombaire latéralisée du côté droit. Là on a une autre hernie discale qui est foraminale et extraforaminale.

Alors quelle est la place de l'imagerie par résonance magnétique ? L'imagerie par résonance magnétique n'est pas toujours indispensable pour le diagnostic de la sciatique par hernie discale. Alors il trouve son intérêt dans les récurrences, c'est-à-dire chez les patients qui sont opérés et qui présentent une récurrence. Et là l'IRM trouve son intérêt pour confirmer une véritable récurrence d'une simple fibrose post-opératoire, chose que le scanner ne peut pas faire, c'est-à-dire que le scanner lombosacré ne peut pas différencier entre une véritable récurrence d'hernie discale d'une simple fibrose post-opératoire.

D'autres examens peuvent être demandés chez les malades présentant une sciatique par hernie discale, l'EMG, c'est-à-dire l'électromyogramme, pour confirmer la souffrance radiculaire. Donc l'électromyogramme, c'est pour calculer la vitesse de conduction motrice et sensitive de la racine nerveuse S1 et S5 pour essayer de mettre en évidence une souffrance radiculaire par la hernie discale. On peut compléter dans le cadre d'un bilan d'opérabilité par une numération formide sanguine, par une vitesse de sédimentation, par un groupe à sanguins, par un bilan d'hémostase ou par une étude de la fonction rénale en vue d'avoir une

idée sur le bilan d'opérabilité sur le malade et candidat à une chirurgie.

Alors ça c'est une IRM chez un patient présentant une sciatique par hernie discale, où on voit la hernie discale à ce niveau entre L5 et S1, on la reconnaît là sur les coupes axiales et là aussi on la retrouve sur les séquences pondérées, sur les coupes sagittales en séquences pondérées T2. Alors cette sciatique par hernie discale, elle peut avoir plusieurs formes cliniques. Il y a ce qu'on appelle les formes hyperalgiques, c'est-à-dire les formes hyper douloureuses, les sciatiques par hernie discale parésiantes, avec des difficultés de la marche sur les pointes ou sur les talons.

Il y a les sciatiques paralysantes, où le malade a carrément une paralysée du membre inférieur. Il y a les sciatiques compliquées par un queue de cheval. Les formes tranquées, c'est-à-dire où la douleur s'arrête, il commence au niveau du bas du dos, il intéresse la fesse, mais il n'arrive pas au niveau des jambes, il s'arrête au niveau du creux poplité.

On dit que le malade a une sciatique tranquée, c'est-à-dire une sciatique qui s'arrête au niveau du creux poplité du membre inférieur. Il y a les formes bilatérales droite et gauche, il y a aussi les formes à bascule. C'est quoi les formes à bascule ? C'est les formes où le malade, parfois il souffre à droite, parfois il souffre à gauche.

Alors la sciatique par hernie discale, c'est une douleur ressentie au niveau du membre inférieur, mais toute douleur au niveau du membre inférieur ne veut pas dire automatiquement hernie discale. Et donc il y a des problèmes de diagnostic différentiel qu'il faut éliminer avant de retenir le diagnostic par hernie discale. Parmi les diagnostics différentiels, il y a ce qu'on appelle les sciatiques non disciales, c'est-à-dire qui ne sont pas dues à une hernie discale.

C'est ce qu'on voit dans les tumeurs vertébrales, lombaires et sacrées. Dans les spondylodécides, tuberculoses ou à germes banales. Dans les malades qui présentent un canal lombaire étroit et chez les malades qui présentent des spondylodécides.

Tous ces cas et toutes ces pathologies peuvent donner une douleur sciatique au niveau du membre inférieur et qui n'est pas due à une hernie discale. Il y a les sciatiques dites tranquillaires, c'est-à-dire qui sont dues à une compression du tronc nerveux sciatique en dehors du canal rachidien. C'est ce qu'on voit dans certains tumeurs pélvienues du rectum, dans certains tumeurs de l'ovaire ou dans certains tumeurs de l'hétérus.

Dans certains cas de traumatisme du bassin, le traumatisme peut être responsable d'une compression du nerf sciatique en dehors du canal rachidien. Certaines injections intramusculaires peuvent atteindre le nerf sciatique et être responsables d'une douleur sciatique en dehors du canal rachidien. La radiothérapie peut être compliquée par une inflammation du nerf sciatique et être à l'origine d'une douleur simulant une sciatique par hernie discale alors qu'elle n'est pas due à une hernie discale.

Dans ce chapitre de diagnostic différentiel, il y a d'autres syndromes douloureux qui peuvent simuler une sciatique par hernie discale. C'est ce qu'on voit dans les coxarthroses et les

gonarthroses, c'est-à-dire l'arthrose de l'articulation coxo-fémorale ou l'articulation du genou qui peuvent donner des douleurs simulant une sciatique. Il faut bien examiner ces malades pour voir si l'articulation coxo-fémorale ou l'articulation du genou ne présente pas de problème pour éliminer ces pathologies et retenir le diagnostic par hernie discale.

Et puis, il y a un autre diagnostic qui est important, c'est celui des artérites du membre inférieur, c'est-à-dire que c'est des pathologies vasculaires qu'on voit surtout chez les sujets de sexe masculin et tabagique le plus fréquemment et qui peuvent présenter des douleurs du membre inférieur pouvant simuler le diagnostic d'une sciatique par hernie discale, mais ce qui fait la différence, c'est que dans ces artérites du membre inférieur, on a un problème du pot artériel au niveau du membre inférieur qui peut être diminué ou carrément aboli dans les artérites du membre inférieur alors qu'il est normal dans les sciatiques par hernie discale. Et donc, c'est pourquoi on a dit dans l'examen clinique, la palpation des pots artériels au niveau du membre inférieur, il doit faire partie de l'examen clinique du patient pour être sûr que le pot fémoral, le pot au niveau des membres inférieurs fémorale et le pot fémoral, le pot pédiex et le pot artériel, le pot du poplité, ils sont bel et bien palpés au niveau de ces régions pour ne pas passer à côté d'une artérite des membres inférieurs et retenir à tort le diagnostic d'une sciatique par hernie discale. Alors, nous avons vu quelle est la présentation clinique du malade, quels sont les examens paracliniques à demander pour confirmer le diagnostic de sciatique par hernie discale, quels sont les diagnostics différentiels qu'il faudra éliminer avant de retenir le diagnostic de sciatique par hernie discale.

Voyons maintenant comment on traite ces malades présentant des sciatiques par hernie discale. Le but du traitement, c'est de soulager le malade de ses douleurs et d'éviter l'évolution vers les complications. Donc, il ne faut pas que la sciatique par hernie discale évolue vers la paralysie ou vers le syndrome de la queue de cheval.

Les moyens qui doivent être à notre disposition pour répondre à ces objectifs, ils sont médicaux et chirurgicaux. Les moyens médicaux, ils sont basés sur le repos, l'immobilisation du rachis par une ceinture d'urso-lombaire lombost, la prescription d'antalgique, la prescription de myorelaxant pour relâcher les muscles paravertébraux qui peuvent être contractés, l'administration et la prescription d'anti-inflammatoires non stéroïdiens et ou de corticoïdes pour traiter la composante inflammatoire de la hernie discale. On peut aussi faire appel à des moyens de rééducation physique du dos, de la musculature et surtout si on a un déficit moteur et ou sphinctérien.

On peut aussi faire appel à la chirurgie chez ce genre de malade présentant une sciatique par hernie discale et le geste chirurgical qu'on réalise chez ce patient, il s'appelle disectomie. Disectomie, c'est-à-dire ablation du disque qui a fait hernie et qui comprime la racine. La disectomie, c'est l'ablation du disque hernié pour décompresser la racine.

Cette disectomie, elle est généralement faite par voie postérieure et elle peut se faire par une chirurgie conventionnelle, c'est-à-dire une chirurgie ouverte. Parfois, certains équipes l'opèrent

sous endoscopie. Alors, voici une vue opératoire où on voit la racine, elle est là et la hernie discale, elle est là.

Quand on enlève moyennant une curette, là on a retiré la hernie discale et on voit la racine qui est devenue libre, elle n'est plus comprimée. Alors, quelles sont les indications thérapeutiques? Il faut savoir que le traitement de la sciatique par hernie discale non compliquée, j'insiste là dessus, c'est-à-dire la hernie discale non compliquée par une paralysie ou par un syndrome de la côte chevale. Alors, si ce genre de patient, le traitement il est d'abord médical, basé sur le traitement antalgique, les traitements anti-inflammatoires, les myorrelaxants, le repos.

Et donc, ce traitement médical, il doit être instauré en première intention, bien entendu en dehors des formes graves, c'est-à-dire des formes paralysantes, paralysantes ou compliquées par un syndrome de la côte chevale. Et ce traitement médical, il doit être suffisamment prolongé, ce qui est préconisé, c'est 6 à 8 semaines de traitement médical. La chirurgie, il a deux indications en matière de sciatique par hernie discale.

Les formes rebelles, c'est-à-dire les formes qu'on aura traitées médicalement pendant 6 à 8 semaines et malgré ce traitement médical prolongé pendant 6 à 8 semaines, lorsque le malade continue à souffrir, il faut lui proposer un geste chirurgical. Et puis, la chirurgie, elle doit être proposée d'emblée chez les malades, chez les formes graves, c'est-à-dire les formes paralysantes, paralysantes ou les formes compliquées par un syndrome de la côte chevale. Alors, quelles sont les modalités évolutives? Un traitement médical bien conduit dans une forme non compliquée, il peut être responsable d'une guérison dans 90% des cas.

Un traitement chirurgical bien réalisé en respectant l'indication, il peut être responsable d'un taux de guérison de 95% des cas. Alors, 5%, ils peuvent présenter ce qu'on appelle une récurrence post-opératoire. Alors, la récurrence, il peut être dû soit à un curtage incomplet du disque ou bien à une exclusion d'un nouveau fragment qu'on aura laissé et qu'on n'aura pas élevé quand on a opéré un malade.

Et puis, la récurrence de la douleur sciatique, elle peut être aussi expliquée par une fibrose post-opératoire. Le pronostic de cette pathologie, il dépend de la rapidité et de la qualité de prise en charge, c'est-à-dire plus on diagnostique rapidement, plus on traite correctement le malade, plus le malade est là de son dévoué favorablement. Donc, en conclusion, la sciatique par hernie discale, c'est une pathologie fréquente en pratique médicale courante et elle est due à un conflit entre le disque et la racine nerveuse suite à la migration du nucleus pulposus à travers l'annulus pulposus du disque intervertébral.

Le diagnostic de la sciatique par hernie discale, il est basé sur la clinique et il peut être confirmé simplement par le scanner lombo-sacré. Parfois, on peut faire à une IRM éventuellement. Attention au diagnostic différentiel et je fais allusion au sciatique non-discale.

Rappelez-vous les tumeurs pélviques et aux autres pathologies non-discales, notamment les artérites du membre inférieur. Le traitement d'une sciatique est d'abord un traitement médical

quand la forme n'est pas grave et lorsque la forme est grave, compliquée, la chirurgie doit s'imposer d'emblée. Donc, retenez que le traitement est d'abord médical dans les formes non compliquées.

Et il faut insister sur la prévention en luttant contre les facteurs favorisants, notamment le port de charges lourdes, l'obésité, par exemple, qui sont des facteurs favorisants sur lesquels il faut agir pour ne pas courir le risque de développer une hernie discale et donc une sciatique par hernie discale. Merci beaucoup.